

Normativas para el Tratamiento de la Esquizofrenia

María Laura Casal

Hernán Martínez Glattli

Para el tratamiento de la esquizofrenia se consideran las siguientes fases:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Fase aguda2. Fase de estabilización3. Fase de mantenimiento |
|--|

Fase Aguda

Es el tratamiento de la fase activa de la esquizofrenia.

Se puede comenzar con un antipsicótico típico o con un antipsicótico atípico (excepto con la Clozapina). Si estos resuelven el episodio agudo se mantienen hasta pasar a la siguiente fase.

Si comenzamos con un antipsicótico típico y éste produce en el paciente efectos adversos que son intolerables, podemos pensar en cambiar a otro antipsicótico típico o pasar a algún antipsicótico atípico.

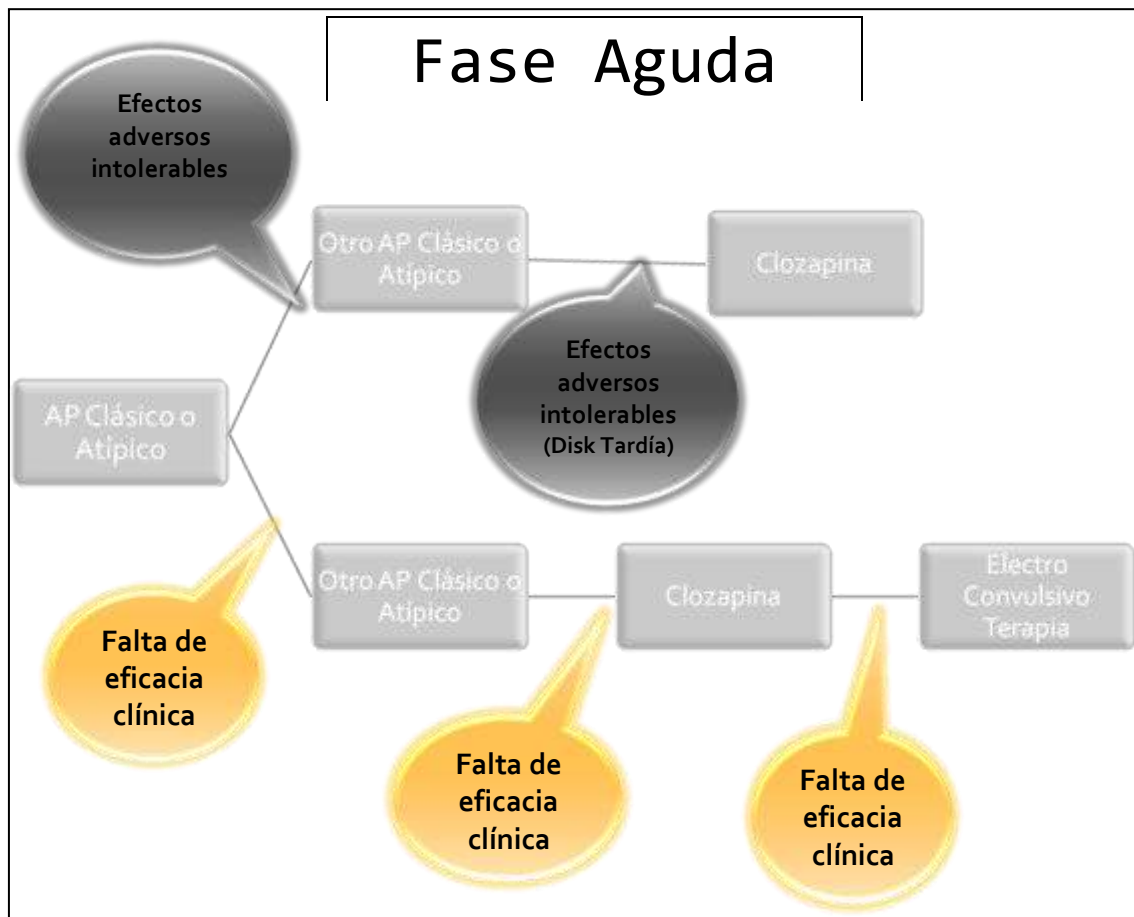
Si, en cambio, comenzamos con un antipsicótico atípico y le produce efectos adversos que no puede soportar, vamos a tener que pasar a otro antipsicótico atípico. Y si de todas maneras, en cualquiera de las dos situaciones, el segundo antipsicótico le produce al paciente efectos que no puede tolerar, (como

por ejemplo una disquinesia tardía) ahora sí, vamos a tener que darle Clozapina.

Pensemos ahora que comenzamos el tratamiento de la fase aguda de la esquizofrenia de la misma manera, con un antipsicótico típico o con un antipsicótico atípico. Y que en esta situación no le provoca al paciente efectos intolerables. Pero sí nos encontramos con una falta de eficacia terapéutica. En este caso también vamos a cambiar de antipsicótico de la siguiente manera: si comenzamos con un típico cambiaremos a otro típico o vamos a pasar a un atípico. Y si hubiéramos comenzado con un atípico pasaremos a otro atípico.

Supongamos que aún así no conseguimos la eficacia clínica esperable entonces tenemos que optar acá también por la Clozapina.

Si en el cuadro clínico del paciente, aún tomando Clozapina, no se resuelven los síntomas psicóticos y, sobre todo, si tiene ideas suicidas o agresividad, el recurso terapéutico de acuerdo a las normativas internacionales es utilizar electroconvulsivo terapia (ECT o Electroshock).



Fase de Estabilización

La fase de estabilización es el período que comienza una vez que se resuelve la fase aguda. Esto es a partir del momento en el cual el paciente respondió adecuadamente al tratamiento.

El objetivo de esta fase de estabilización es evitar la recaída y mejorar la sintomatología. El tiempo establecido es de 3 a 6 meses, y se utilizan las mismas dosis que en la fase aguda.

La desventaja de esta etapa del tratamiento es que al usar altas dosis de antipsicóticos por un largo período, suele aumentar la frecuencia de aparición de efectos adversos, como los síntomas negativos y las disquinesias tardías. En la Argentina, a diferencia de lo que se hace en los países sajones, no es frecuente seguir el tratamiento

con las dosis utilizadas en esta fase, pasándose directamente a la fase de mantenimiento.

Fase de Mantenimiento

En nuestro país es la fase que sigue a la fase aguda.

En términos generales si se resolvió la fase aguda con un antipsicótico típico, como primer paso, podemos disminuir la dosis o cambiar a un atípico.

De acuerdo al número de episodios, el tratamiento va a ser distinto.

Si es el primer episodio en la vida del paciente o el primero en los últimos 5 años, una vez que pasó la fase aguda se disminuye el antipsicótico al 20% de la dosis que fue efectiva (por ejemplo de 20 mg/día pasaremos a 5 mg/día). Si no tiene recaídas, vamos a

mantener esta misma dosis por un año, momento en el cual empezaremos el retiro del antipsicótico. Esto se lleva a cabo disminuyendo un 10% de la dosis total por mes. Si tenemos en cuenta que la frecuencia de recaídas en la esquizofrenia es muy alta y que cada una

de estas provoca deterioro en el paciente y empeora el trastorno, en un paciente con un diagnóstico muy claro de esquizofrenia deberíamos pasar a un antipsicótico atípico y mantener este tratamiento de manera crónica.



Esquizofrenia Resistente:

Se considera Resistente a la Esquizofrenia que a pesar de haber sido tratada con dos antipsicóticos

por seis semanas cada uno, en dosis consideradas suficientes para el efecto terapéutico, no respondió de manera favorable. En este caso,

como vimos anteriormente, se utiliza la Clozapina.

Siempre hay que recordar que la Clozapina si bien es uno de los antipsicóticos más eficaces puede presentar graves efectos adversos hematológicos (granulocitopenia o agranulocitosis por depresión de la función de la médula ósea). Por esto hay que realizar controles periódicos de los valores de glóbulos blancos en la sangre.

Algunas características fármacológicas de los antipsicóticos a tener en cuenta:

Actualmente se tiende a utilizar antipsicóticos atípicos por la baja incidencia de efectos adversos, pero por razones de accesibilidad en nuestro país es muy frecuente el uso de los antipsicóticos típicos.

- **Haloperidol:** Es el antipsicótico típico que se sigue utilizando de manera mas frecuente. Se lo usa en excitación psicomotriz por la baja incidencia de efectos adversos graves en el uso agudo (extrapiramidales). También se lo usa habitualmente en los tratamientos crónicos cuando no se tiene acceso a antipsicóticos atípicos. Pero conlleva un alto riesgo de efectos adversos a largo plazo como la disquinesia tardía.
- **Tioridazina:** Provoca hipotensión y bloqueo muscarínico (anticolinérgico) con su consecuente taquicardia refleja. Esto es de riesgo para ancianos y personas con alteraciones cardiológicas, por lo cual hay que evitar su uso.
- **Clorpromazina:** Uno de sus efectos es el enlentecimiento de la conducción cardíaca (prolonga

QT). Hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene patología cardíaca previa. Debe ser evaluado por un cardiólogo.

- **Clozapina:** es el antipsicótico mas eficaz. No olvidar los efectos adversos hematológicos, disminución de los glóbulos blancos, entre ellos los neutrófilos, lo que hace que el paciente quede expuesto a sufrir graves infecciones. Además suele producir Síndrome Metabólico.
- **Risperidona:** A dosis de hasta 6 mg/día se comporta como antipsicótico atípico provocando nulo o poco de los síntomas extrapiramidales y de la prolactina. Con dosis mayores, a partir de 8 mg/día se comporta como típico.
- **Olanzapina:** Puede provocar aumento de las enzimas hepáticas, lo que nos marca algún grado de daño del hígado que habrá que evaluar. Además junto con la Clozapina, produce con mucha frecuencia Síndrome Metabólico.
- **Quetiapina:** Más allá de otras características, no descuidar el hecho de que puede producir o empeorar las cataratas, por lo cual hay que realizar un examen oftalmológico.
- **Ziprasidona:** Puede aumentar la prolactina. Puede también prolongar el QT, pero no tanto como la clorpromazina. Aún así hay que evaluar cardiológicamente al paciente.
- **Aripiprazol:** Recordar que aunque es una medicación

agonista parcial dopaminérgica, puede provocar empeoramiento de los síntomas del Parkinson.

Síndrome Metabólico:

Si bien los antipsicóticos atípicos tienen un perfil de efectos adversos más favorable que los típicos, provocan con cierta frecuencia el llamado Síndrome Metabólico. Este síndrome está caracterizado por el aumento de peso junto con el aumento de grasa abdominal, aumento de triglicéridos (un tipo de lípidos), disminución del colesterol HDL (el llamado “colesterol bueno”); hipertensión arterial e hiperglucemia en ayunas. Además de provocar abandonos del tratamiento por parte del paciente principalmente porque engorda, aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares e infartos cardíacos.

Todos los antipsicóticos atípicos pueden provocar este síndrome. Los que más riesgo tienen son la Clozapina y la Olanzapina. Los que menos lo producen son la Ziprasidona y el Aripiprazol.